確認順：①成分判別→②年齢確認
→③包装確認→④レジ確認

薬剤別 包装区分 早見表

作成日: 2026/10/28
※AIによる試作品/使用前に最新の添付文書等を確認

【法解釈・実務鉄則】小容量1個の販売時であっても、18歳未満には「氏名・年齢の確認」、成人には「他店での直近購入状況の確認」が法令上必須となります。
※1日量は「適宜増減」や小児用量に関わらず、成人の1日最大服用量で計算。「就寝前にも服用可」「頓服可」で回数が増える場合は、その分も足した最大量で計算します。
★前提：新しい包装なら、まずパッケージの「要」の囲み（大容量の目印）を見る。囲みのない旧包装の判断や、お客様からの質問対応にこの表を使います。

① 成分判別:
- ● 対象(指定8成分)=エフェドリン類3種：エフェドリン/メチルエフェドリン/プソイドエフェドリン ＋その他5種：コデイン/ジヒドロコデイン/デキストロメトルファン(DXM)/ジフェンヒドラミン/ブロモバレリル尿素
- ● 対象外(紛らわしい)=生薬マオウ（エフェドリンを含むが生薬主体の製剤は通知で除外）／無水カフェイン／プロメタジン等の他の抗ヒス／アリルイソプロピルアセチル尿素（8成分外）
- ■ 対象外(外用剤)=トローチ・舌下錠などの口腔用錠剤、含嗽剤、口腔用スプレー、軟膏、目薬等（通知で外用剤と明記。8成分はすべて外用剤を除く）
- ■ 要注意(のど飴)=医薬品のドロップはトローチと違い内服扱い。成分で判定（例：ルルメディカルドロップ＝メチルエフェドリン配合）（医薬部外品・食品ののど飴は対象外）

18歳未満: 小容量1個のみ販売可。大容量・複数個(種類違いの対象薬も合算)は家族用でも理由問わず一律禁止（販売不可）
18歳以上: 小容量は通常販売可。成人であれば購入個数の制限はないが、大容量・複数個の購入は理由確認が必須（正当な理由がなければ販売不可）
② 年齢確認: 見た目で18歳以上と判断できない場合、学生証・健康保険証・マイナンバーカード・運転免許証等の身分証で氏名・年齢を確認
※見た目の判断には個人差があります。年齢の確認は薬機法第36条の11に基づく確認義務の一部のため、迷ったら確認する
③ 包装制限の確認: 下表で商品名を検索し「小包装/大包装」どちらの区分か確認（×7＝かぜ薬・解熱鎮痛薬・鼻炎用内服薬／×5＝それ以外）
※×7区分は、風邪の諸症状や長引く頭痛・鼻炎など症状が1週間程度続くことが臨床上多いための設定です
※表にない商品は、KEGG_OTC検索欄で成分・用量を見て、下の計算ドリルの手順で判定できます
よくある質問: 対象薬を種類違いで1個ずつ購入→複数個扱いで販売不可/身分証の提示が難しい→年齢・氏名を確認できる方法がないか丁寧に確認

計算ドリル

表にない商品も、この3ステップで小容量／大容量を判定できます

❶ 基準日数を決める
かぜ薬・解熱鎮痛薬・鼻炎用内服薬 →×7（7日）
それ以外（せき止め・乗り物酔い薬等） →×5（5日）

❷ 消費日数を計算する
包装数量 ÷ 1日量 ＝ 消費日数
1日量＝成人(15歳以上)の最大量（就寝前・頓服も足す）

❸ 基準日数と比べる
消費日数 ≦ 基準日数 →小容量
消費日数 ＞ 基準日数 →大容量（同日数は小容量）

例）改源 26包：かぜ薬 → ×7（7日）／ 26包 ÷ 3包 ＝ 8.7日 ＞ 7日 → 大容量
ブランド速断: 原則対象:ルル・パブロン(50除く)・ベンザブロック｜対象外:セデス・ノーシン・バファリン・イブ　※表の作成時に調べた範囲の目安。新発売品は反映されていないため、迷ったら成分で確認

薬剤名 小包装＝単品1個は18歳未満も可／大包装＝18歳未満へ不可 1日量＝成人(15歳以上)の1日最大服用量（18歳未満の購入者でも、常にこの量で計算）	対象成分	1日量 ×7＝かぜ薬等 ×5＝それ以外	区分	小包装	境界	大包装	レジ確認フロー
アネトンせき止め錠	リン酸コデイン, メチルエフェドリン	12錠	×5	48錠	60錠		18歳未満の疑い →身分証等で 氏名・年齢を確認
ウット	ブロモバレリル尿素, ジフェンヒドラミン	3錠	×5	9錠 12錠 †	15錠		
トラベルミン	ジフェンヒドラミン	3錠	×5	6錠	15錠		
ドリエル	ジフェンヒドラミン	2錠	×5	6錠	10錠	12錠	
ナロンエースT	ブロモバレリル尿素	6錠	×7	24錠	42錠	48錠 84錠 †	
ナロン錠	ブロモバレリル尿素	6錠	×7	24錠	42錠	48錠	
パイロンPL錠 ゴールド	デキストロメトルファン	6錠	×7	18錠 30錠 †	42錠		小容量1個のみ の購入？
パブロンSせき止め	ジヒドロコデイン, メチルエフェドリン	6カプセル	×5	12カプセル 24カプセル †	30カプセル		
パブロンゴールドA〈錠〉	ジヒドロコデイン, メチルエフェドリン	9錠	×7		63錠	130錠 210錠 †	
ベンザブロックIP※	ジヒドロコデイン, メチルエフェドリン	6錠	×7	18錠 30錠 †	42錠		
ベンザブロックIP錠	ジヒドロコデイン, メチルエフェドリン	9錠	×7	30錠 45錠 †	63錠		
ベンザブロックIPプレミアム(2025年廃版)※	ジヒドロコデイン, メチルエフェドリン	6錠	×7	12錠 24錠 †	42錠		
ベンザブロックL※	ジヒドロコデイン, プソイドエフェドリン	6錠	×7	18錠 30錠 †	42錠		【いいえ】 大容量/複数個 18歳未満→一律禁止 18歳以上→理由確認
ベンザブロックLプレミアムDX※	デキストロメトルファン プソイドエフェドリン	6錠	×7	12錠 24錠 †	42錠		
ベンザブロックLプレミアムDX錠	デキストロメトルファン プソイドエフェドリン	9錠	×7	30錠 45錠 †	63錠		
ベンザブロックS※	ジヒドロコデイン, メチルエフェドリン	6錠	×7	18錠 30錠 †	42錠		
ベンザブロックSプレミアムDX※	デキストロメトルファン プソイドエフェドリン	6錠	×7	12錠 24錠 †	42錠		
ベンザブロックTプレミアムDX※	ジヒドロコデイン, dl-メチルエフェドリン	6錠	×7	12錠 24錠 †	42錠		【はい】小容量1個 18歳未満→氏名＋ 周辺状況確認 18歳以上→周辺状況確認
メジコンせき止め錠Pro	デキストロメトルファン	6錠	×5	20錠	30錠	40錠	
レスタミンコーワ糖衣錠/Uコーワ錠	ジフェンヒドラミン(Uはビタミン等配合)	9錠	×5		45錠	75錠 80錠 120錠 †	
ロキソニン総合かぜ薬	ジヒドロコデイン, メチルエフェドリン	6錠	×7	12錠 24錠 †	42錠		
改源	メチルエフェドリン	3包	×7	9包	21包	26包 60包 †	
新カイゲンせき止め液W	ジヒドロコデイン, メチルエフェドリン	60mL	×5	120mL	300mL		条件を満たせば 販売可
新コンタック600プラス	プソイドエフェドリン	4カプセル	×7	20カプセル	28カプセル	40カプセル 60カプセル †	
新ブロン液エース	ジヒドロコデイン	60mL	×5	120mL	300mL		
新ルルAゴールドDXα	デキストロメトルファン, メチルエフェドリン	9錠	×7	30錠 60錠 45錠 †	63錠	90錠	
ｱｽﾄﾌｨﾘﾝS	メチルエフェドリン, ジフェンヒドラミン	3錠	×5		15錠	45錠	

※＝カプレット表記（ベンザブロック○○/末尾「錠」なし）。1日成分量は「○○錠」と同一ですが服用粒数が異なります。
†＝同じ区分（小包装/大包装）内に複数の包装規格（新旧パッケージ等）があります。該当する数量はお手元のパッケージの表示で確認してください。

判定注意・参考 ※該当はまれです	指定濫用判定	同ブランド内比較・注釈（「対比:」＝取り違え注意ポイント）
アレグラFX (2錠中)フェキソフェナジン120mg	【対象外】	対比: FX(通常版)は対象外/プレミアムのみ血管収縮剤(プソイドエフェドリン)追加で該当。
コリホグス (2錠中)クロルゾキサゾン300mg/エテンザミド300mg/カフェイン水和物50mg	【対象外】	中枢抑制作用による呼吸抑制リスク。アルコール・ベンゾ系併用/ODに要注意。
トラベルミンR (1錠中)ジフェニドール16.6mg/スコポラミン0.16mg/無水カフェイン30mg/ピリドキシン5mg	【対象外】	対比: R・ジュニア・ファミリー・「1」は対象外/無印(大人用)のみジフェンヒドラミン含有で該当。
ナロン錠 (2錠中)アセトアミノフェン265mg/エテンザミド300mg/ブロモバレリル尿素200mg/無水カフェイン50mg	この商品名は【該当】	ナロン系（確認済）：該当＝ナロン錠(無印)・ナロン顆粒・ナロンエースT／対象外＝ナロンm・エースプレミアム。
パイロンPL錠(無印)	【対象外】	対比: PL錠・PL錠Pro・PL顆粒・PL顆粒Proは対象外/PL錠ゴールド・溶かしてのむかぜ薬は該当。
新コンタック鼻炎Z (1錠中)セチリジン10mg	【対象外】	対比: 鼻炎Zのみ対象外(唯一制限成分なし)/600プラス・かぜ総合等は該当。※セチリジンは妊婦禁忌。
新ルルAゴールドDXα (9錠中)クレマスチン/ベラドンナ総アルカロイド/ブロムヘキシン/トラネキサム酸/アセトアミノフェン/dl-メチルエフェドリン/デキストロメトルファン/無水カフェイン	この商品名は【該当】	対比: 同じ「ルル」でも、ルルのど飴(医薬部外品)は対象外。メディカルドロップ(医薬品)は成分で該当。
葛根湯エキス錠S「コタロー」 (12錠中)葛根湯エキス2.2g(カッコン/マオウ/タイソウ/ケイヒ/シャクヤク/カンゾウ/ショウキョウ)	【対象外】	対比: 葛根湯・小青竜湯等の漢方製剤は対象外(マオウは化学成分外で規制対象外)。

免責: 過去に用法用量超過の自己判断服用で重篤な健康被害が生じた事例を踏まえた確認です。意図的な過量服薬は保証・救済制度の対象外です。
参考：商品検索（表にない商品はこちら）　aimsoaringhaiku.github.io/pharma-gatekeeper/
準拠: 厚生労働省 局長通知「指定濫用防止医薬品の指定について」・厚生労働大臣が定める数量（告示）
JSMI「指定濫用防止医薬品の販売制度について」／兵庫県 薬務課 制度改正資料

参考：商品検索　ご意見・改善案

【2枚目】販売判断の表現案

（上段＝レジでの確認事項　／　下段＝状況別対応のポイント）

④ レジでの確認事項　※該当する場合は下段「状況別対応のポイント」を参照

＋【使用者】今回のお薬は、どなた（ご本人様／12歳未満の小児等）が使われますか？

＋ いつから、どの程度の症状ですか？（適正な使用期間の確認、長引く場合は受診勧奨を判断します）

＋ すでに受診・服薬を開始していますか？（重複投与や飲み合わせ確認のため）

①【年齢・氏名】18歳未満ですか？

（※法令上の確認。18歳未満への大容量・複数個は一律販売不可。お客様には「お薬を安全にお使いいただくための確認です」と説明）

②【重複】他店や他のレジで同じお薬（風邪薬、咳止め等）のご購入はありませんか？

（譲り受けも含みます）

以下は、お薬の安全な選択に関わります。

③【体質】アレルギー歴（アスピリン喘息等）や、喘息、不整脈、緑内障、前立腺肥大等の持病・治療中の病気はありますか？

④【併用】現在、病院で処方されたお薬や、他のお薬を飲まれていますか？（SSRI等との重複防止）

⑤【妊婦】妊娠中（週数）、または授乳中ではありませんか？（妊娠後期のNSAIDs禁忌、授乳中のコデイン避止）

＋ このお薬（または同じ成分）を使ったことはありますか？そのとき副作用はありませんでしたか？

＋【大容量・複数個（成人）】

（※18歳以上であれば購入個数の制限はございませんが、ご理由を伺わなければならない厚労省の規則がございます）

免責: 過去に用法用量超過の自己判断服用で重篤な健康被害が生じた事例を踏まえた確認です。意図的な過量服薬は保証・救済制度の対象外です。

④ 状況別対応のポイント

表記：■赤字＝特に重大な注意（禁忌・販売不可など）／▶黒字＝一般的な注意。「禁忌」はOTC添付文書の「してはいけないこと」に相当（医療用で「慎重投与」の成分でも、OTCでは「してはいけない」になる場合がある）。

①②年齢・重複　18歳未満/複数個(他店合算)希望

■18歳未満：大容量・複数個は理由不問で一律不可(家族用も例外なし)。

■12歳未満：コデイン系(ジヒドロコデイン含)絶対禁忌⇒他成分の咳止めへ。

▶身分証拒否：年齢確認不能のため販売不可。

※使用期間の目安　「いつから・どの程度の症状か」で長引いているかを判断

▶かぜの症状は通常、数日でピークを越え1週間前後で改善に向かう(×7区分の根拠)。

▶かぜ薬・せき止め・解熱鎮痛薬の添付文書は多くが「5〜6回服用しても改善しなければ中止して相談」。

▶せき：3週間以上続けば遷延性、8週以上は慢性咳嗽(咳嗽・喀痰の診療ガイドライン)⇒受診勧奨。

+大容量・複数個の理由可否(18歳以上)　買い置き/家族分/海外渡航等を理由に希望

▶正当な理由の例：家庭の常備薬、同症状の家族分、海外赴任・旅行携行、異なる薬効の併用目的。

▶ただし理由があれば無条件可ではなく、数量が適切か薬剤師等が個別判断する。

③体質(アレルギー)　解熱鎮痛薬でアレルギー歴⇒皮膚か呼吸器かを確認

▶皮膚(ピリン疹などの発疹)：ピリン系以外のNSAIDs(ロキソプロフェン等)へ代替可。

■呼吸器(アスピリン喘息)：NSAIDs全般に交差反応で全てNG⇒アセトアミノフェン(AAP)単剤のみ提案。

③体質(喘息・不整脈等)　喘息/不整脈/緑内障/前立腺肥大/高血圧・糖尿病

▶抗コリン薬・第一世代抗ヒス：喘息=痰粘稠化、不整脈=頻脈・QT延長。

▶緑内障=眼圧上昇、前立腺肥大=尿閉⇒単一成分薬を推奨。

■プソイドエフェドリン：上記に加え高血圧・心疾患・糖尿病・甲状腺機能亢進も対象。

※抗ヒスタミン薬の使い分け　喘息の既往がある方への風邪薬・鼻炎薬の相談

▶第一世代(市販の風邪薬・せき止め等)：原則避ける⇒気道を乾燥させ痰をドロドロにし「痰の嵌頓」を招く危険性(クロルフェニラミンマレイン酸塩等)。

▶第二世代(病院のアレルギー薬・一部の市販鼻炎薬)：比較的安全⇒気道を乾燥させる副作用がほとんどない(アレグラ/フェキソフェナジン、クラリチン/ロラタジン等)。

▶喘息タイプで判断：アレルギー性(花粉・ダニ由来、鼻炎を合併しやすい)は喘息が落ち着いていれば医師処方あり/非アレルギー性(冷気・感染由来)は抗ヒスタミンのメリットがなくデメリットのみのため不要。

※運転　運転前後の服用を心配されたら(半減期の長い成分ほど翌日に持ち越しやすい)

成分(世代)	半減期	⇒回避目安
クロルフェニラミン(1)	12〜24h	翌日まで
プロメタジン(1)	10〜14h	12〜24h
ブロモバレリル尿素	約15h	翌日まで
ブチルスコポラミン(抗コ)	約1.5h	5〜6h控
dl-メチルエフェドリン	約5〜6h	8〜12h
デキストロメトルファン	約3.5h	6〜8h

■当日は運転を避ける成分

成分(世代)	半減期	⇒回避目安
ジフェンヒドラミン(1)	約9h	当日NG
セチリジン(2)	7〜10h	当日NG
ベポタスチン(2)	約2.4h	当日禁止
アゼラスチン(2)	約24h	当日禁止

授乳婦指導(成分別の目安／添付文書の規定ではなく実務上の目安)：

● AAP/イブプロフェン/無水カフェイン(通常量)⇒通常授乳可

● クロルフェニラミン(長期)/プロメタジン/ブロモバレリル尿素⇒搾乳破棄(半減期×3-4h)

● DXM/ジフェンヒドラミン(短期)⇒服薬後2-4h回避

■ コデイン/ジヒドロコデイン(乳児モルヒネ代謝リスク)⇒代替薬へ変更

④併用　SSRI服用中/他剤併用

▶最重要：DXM(デキストロメトルファン)とSSRI等の併用はセロトニン症候群のおそれ(頻度はまれだが重篤化しうる)⇒服用中なら医師・薬剤師へ相談。

▶グレープフルーツジュース(GFJ)でDXM血中濃度↑。マクロライド系/アゾール系はQT延長・心室頻拍に注意。

⑤妊婦・授乳　妊娠中/授乳中と判明

▶妊娠後期のコデイン系は避ける⇒新生児呼吸抑制。DXM単剤(メジコン等)が候補だが、指定成分なので購入制限は同じ。妊婦への可否は添付文書で確認。

■授乳中の抗コリン薬：ロートエキス配合薬は添付文書上「授乳回避」(母乳分泌↓・乳児頻脈のおそれ)。ブチルスコポラミン(ブスコパン等)は添付文書に授乳中断の指示なし⇒成分名で要確認。

■コンタック鼻炎Z(セチリジン)は妊婦投与禁忌。第1世代クロルフェニラミンは比較的安全。

【参考】強心薬(センソ含有)　救心・六神丸等の購入/併用歴の確認

■併用禁忌：センソ含有薬(救心・六神丸等)と医療用強心薬(ジゴキシン等ジギタリス製剤)は併用禁忌⇒不整脈・中毒のおそれ。

▶妊婦は特に注意：センソ・ブシ(附子)は妊娠中の使用に注意を要する成分⇒購入前に必ず確認。

※成分の落とし穴・過量服薬　長期連用・依存・過量服薬の疑い

▶ウレイド系(ブロモバレリル尿素等)：長期乱用⇒臭素蓄積で歩行困難・幻覚(高齢者はせん妄も)。

▶MOH：複合鎮痛薬を月10日超×3ヶ月超服用⇒薬剤乱用頭痛に進展。

■過量服薬：初日=急性心毒性、3日目以降=劇症肝不全(AAP)。AAPは無症状のまま進行。

※外用薬・アンナカ　外用薬/無水カフェインの質問

▶対象外：軟膏・クリーム・目薬等の外用剤(成分含有でも規制対象外)。

▶対象外：トローチ・舌下錠などの口腔用錠剤、含嗽剤、口腔用スプレー(通知で外用剤と明記)。医薬品ドロップは内服扱いで成分次第(4枚目)。

▶対象外：アンナカ(無水カフェイン)。お茶等にも含有、一律規制が非現実的。

※現場で遭遇しやすい主要な注意点の抜粋。全てを網羅するものではありません。

準拠: 厚生労働省 局長通知「指定濫用防止医薬品の指定について」/JSMI「指定濫用防止医薬品の販売制度について」/兵庫県 薬務課 制度改正資料

【3枚目】社内マニュアル参考資料集

（厚労省・薬局配布資料の要点を再構成　／　右下＝赤枠のふり番・脚注）

参考① 購入者への掲示例　　元資料：指定濫用防止医薬品をご購入時フリップ

指定濫用防止医薬品をご購入の皆様へ

指定濫用防止医薬品の濫用をした場合、
保健衛生上の危害が発生するおそれがあります。

指定濫用防止医薬品の販売にあたり、OTC医薬品の各区分で
確認する事項に加え、以下を確認させていただきますので
ご理解の程よろしくお願いします。

購入者が18歳未満の場合、複数個・大容量の販売はできません。

- ☐ 年齢
- ☐ 購入しようとする者が18 歳未満である場合には、当該者の氏名
- ☐ 他の薬剤又は医薬品の使用の状況
- ☐ 当該製品及び他の指定濫用防止医薬品の購入又は譲り受けの状況
- ① ☐ 大容量製品又は複数個の購入に該当する場合、その理由
- ☐ 適正な使用であることを確認するために必要な事項
- ☐ その他、情報提供を行うために必要な事項

情報提供内容

①医薬品の名称
②医薬品の有効成分の名称及びその分量
③医薬品の用法及び容量
④医薬品の効能又は効果
⑤その他医薬品を販売等する薬剤師がその適正な使用のために必要と判断する事項



適正な使用を確保できないと判断した場合には
販売を行いませんのでご了承ください

ミアヘルサ薬局
merhälsa

参考② 制度改正のお知らせ　　元資料：薬物濫用ポスター「大切なお知らせ」

大切なお知らせ　　2026.5/1から

薬物乱用防止のため法律で
「指定濫用防止医薬品」
と定められた製品は、販売方法が変わります。

※市販薬の不適正使用による健康被害が報告されております。

要確認
※表示は一例です

購入時に確認・説明があります
※当薬局では、原則**使用者本人**への販売とさせて頂きます。

1 購入数
18歳未満は
小容量1個のみ
○販売は原則お一人様 1個とさせて頂きます。
○18歳以上で、複数個・大容量をご希望の場合は
購入理由を確認します。
※小容量とは、4～5日分、ただし効能又は効果によっては7日分。

2 年齢確認
年齢等の確認
18歳未満の方は年齢及び氏名
若年者または18歳以上で複数個・大容量の購入を希望される場合は氏名・年齢等を身分証明書等で確認します。
必要に応じて連絡先等を確認することがあります。
みほん

3 使用状況の確認
他の薬局での購入や
併用薬を確認
重複使用や頻回購入がないかを確認します。

4 販売できない場合
適正使用が
確認できない時
薬剤師・登録販売者の判断で販売できないことがあります。

「薬物濫用・薬物依存」の疑いがある場合には、しかるべき対処をし、
法令に基づき副作用報告を行います。

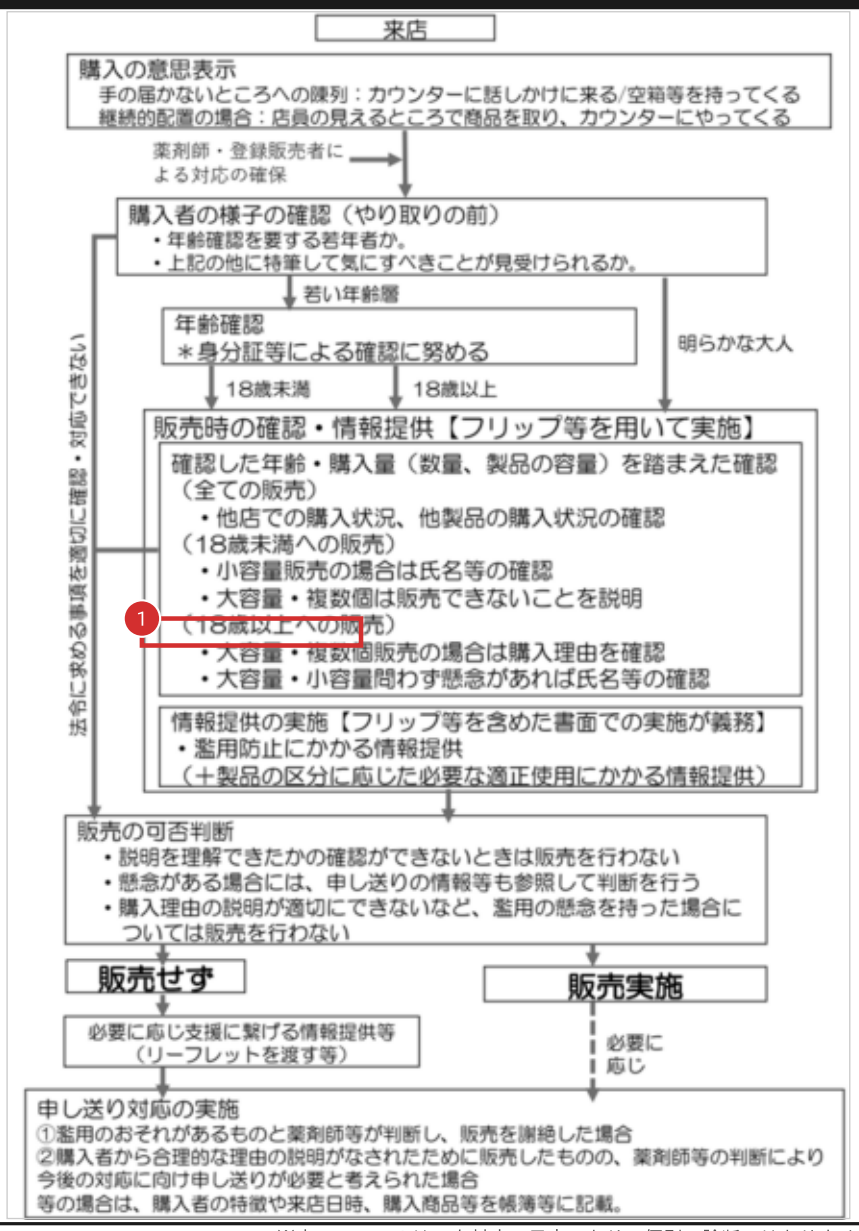
対象商品の目印
外箱などに「要確認」等の表示がある場合があります。ご不明な点は薬剤師または登録販売者へご確認ください。
※表示がない製品でも対象となる場合があります。

表示イメージ
要確認
② 要確認
小容量の例　大容量の例
※実際の表示は製品により異なる場合があります
※総合感冒薬、咳止め薬、鼻炎用内服薬、解熱鎮痛薬等の一部の医薬品が該当します。

指定濫用防止医薬品
以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤(外用剤を除く)
- ○エフェドリン
- ○コデイン
- ○ジヒドロコデイン
- ○ジフェンヒドラミン
- ○デキストロメトルファン
- ○プソイドエフェドリン
- ○ブロムワレリル尿素
- ○メチルエフェドリン

市販の医薬品による対応が適切でないと判断した場合、**受診**等を勧めます。

参考③ 来店～販売可否フロー　　元資料：販売可否判断フローチャート



④ 赤枠のふり番・脚注／確認業務の補足

1 参考①③／理由確認は18歳以上のみが対象

参考①の赤枠「大容量製品又は複数個の購入に該当する場合、その理由」と、参考③の「18歳以上への販売」の分岐は同じことを示しています。理由を確認するのは18歳以上の購入者だけです。18歳未満は年齢確認の時点で、大容量・複数個が理由を問わず販売不可です。

2 参考②／「大容量」の目印

「要確認」の外枠は、小容量・大容量どちらの商品にも付いています。大容量側は「要」の字にさらに丸い囲みが付くことが多いです（表示は製品や年代により異なり、旧い包装には記載がない場合もあります）。

■ 身分証明書提示について（自店ルール）

法令に提示させる書類名の規定はありませんが、確実に確認するため、当店では「公的な身分証明書」（学生証・健康保険証・マイナンバーカード・運転免許証等）の提示をお願いしています。

■ この規制がある理由（免責事項の根拠）

指定濫用防止医薬品制度は、用法用量を超える自己判断の服用による健康被害を防ぐことを目的としています。用法用量を守れば効果と安全性が得られる一方、意図的な過量服薬による健康被害は救済制度の対象外です。

※本マニュアルは一次対応の目安であり、個別の診断ではありません。最終判断は薬剤師・登録販売者の専門的知見に基づき行ってください。

準拠: 厚生労働省 局長通知「指定濫用防止医薬品の指定について」/JSMI「指定濫用防止医薬品の販売制度について」/兵庫県 薬務課 制度改正資料

【4枚目】社内限定・データ整備リファレンス

（上段＝新商品採用時チェックリスト　／　下段＝剤形・医薬品区分の基礎知識）

新商品採用時チェックリスト　※package_verification.csvへの追加担当者向け

STEP1　OTC添付文書の「成分欄」を確認

「成分（N錠中）」の表記は、成人の1日量とみなしてよい。

＊ただし、毎食後に加えて就寝前も服用可等、頓服的に追加可能で1日上限量が可変な場合は、実際の最大服用回数で計算し直す。

STEP2　OTC添付文書の「用法用量欄」を確認

指定濫用防止医薬品の判定は、用法用量が年齢で異なる場合「1日当たりの用量が最も多い年齢」の数量で判断する（医薬発0213第2号、令和8年2月13日）。

多くの製品では実質的に15歳以上の用量が最大になる。小児用量・「適宜増減」は使わない。

STEP3　消費日数を計算し、小容量/大容量を判定

包装数量 ÷ 1日量 ＝ 消費日数。消費日数が基準日数（×7または×5）以下なら小容量、超過なら大容量（1枚目のドリルと同じ計算式）。

STEP4　管理表の作成

（例）package_verification.csv

列の意味：product=商品名／kubun=区分記号(〇:対象品)／package=包装規格／days=消費日数(日)／judgment=容量判定(小容量,大容量)／limit=基準日数(7日 or 5日)／note=備考／ingredients=対象成分／daily_dose=1日量(錠・包等)

入力例（改源 26包）：product=改源, kubun=〇, package=26包, days=8.7, judgment=大容量,
limit=7, ingredients=メチルエフェドリン, daily_dose=3

剤形・医薬品区分の基礎知識

剤形の基本ルール：トローチ（外用）と医薬品ドロップ（内服）は扱いが異なります

■ トローチ・舌下錠などの口腔用錠剤／含嗽剤／口腔用スプレー＝「外用剤」（対象外）

令和8年2月13日の局長通知で、外用剤に「口腔内に適用する製剤（口腔用錠剤（トローチ剤、バッカル錠等）等）」が含まれると明記。

指定8成分はいずれも外用剤を除くため、指定成分を含んでいても対象外。

■ 医薬品のドロップ（のど飴形状）＝「内服」扱い（成分で判定）

トローチとは別に扱い、内服薬と同じく成分欄を確認する。指定成分が入っていれば販売制限の対象。

例：ルルメディカルドロップ（dl-メチルエフェドリン配合、指定第2類医薬品）。古い通知ではドロップもトローチと同じ扱いだったため、旧資料の記載に注意。

「市販ののど飴」の3つのグラデーション

医薬品のドロップ（内服）	浅田飴、ルルメディカルドロップ等⇒指定成分があれば規制対象
指定医薬部外品（のど飴）	ヴィックスメディケイテッドドロップ、ルルのど飴等⇒医薬品ではない（指定成分を配合できない）ため対象外
食品（普通の飴）	龍角散ののど飴、カンロのど飴等⇒お菓子のため対象外

＊店頭で「ドロップ・のど飴」を見るときは、パッケージに「第〇類医薬品」の表示があるかをまず確認し、
医薬品なら成分欄をチェックする（トローチ剤・医薬部外品・食品は対象外）。

医薬品の区分（参考）　※新成分は原則3年間の監視期間で区分見直しの可能性あり

要指導医薬品	薬剤師による対面販売必須。ネット通販不可。購入時に書面での説明と確認がある最上位規制。
第1類医薬品	薬剤師による販売必須。ネット通販は可能だが、購入前にメール等での確認ステップがある。
指定第2類医薬品	登録販売者でも販売可能。禁忌の確認が推奨される（妊婦・ぜんそく既往・依存リスク等）。
	＝＝＝ここまでが「指定濫用防止成分を配合できる」区分＝＝＝
第2類医薬品	強い禁忌や深刻な依存性はない成分。多くの漢方薬・胃腸薬・一部の目薬等が該当。
第3類医薬品	購入時の法的制限が最も緩い、副作用リスクが低い日常的なお薬（ビタミン剤等）。
指定医薬部外品／医薬部外品／食品	指定濫用防止成分は配合不可（指定医薬部外品はコンビニ販売可、「殺菌・消毒／声がれ」等の文言が可）。

準拠: 厚生労働省 局長通知「指定濫用防止医薬品の指定について」/JSMI「指定濫用防止医薬品の販売制度について」/兵庫県 薬務課 制度改正資料

【5枚目】新商品 判定ワークシート（穴埋め式）

早見表にない商品は、KEGG等で添付文書を開き ①→⑤ を上から埋めてください。最後の枠で判定と対応が決まります。

商品名 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　確認日 ＿＿＿＿＿＿　確認者 ＿＿＿＿＿＿

参照先 ☐ KEGG（一般用医薬品）　☐ 添付文書・外箱　☐ その他 ＿＿＿＿＿＿

① 医薬品の区分を確認（外箱・添付文書の「第〇類医薬品」表記）

医薬部外品・食品 → ここで【対象外】

☐ 要指導医薬品　☐ 第1類医薬品　☐ 指定第2類医薬品　☐ 第2類医薬品　☐ 第3類医薬品

↑ いずれかに該当 → ②へ

☐ 指定医薬部外品・医薬部外品・食品（のど飴等）→【対象外】

※第2類・第3類でも成分次第で対象になり得るため、医薬品なら区分に関係なく②へ進む。

② KEGGの「成分」欄で指定濫用防止成分（8成分）を探す

1つもなければ → ここで【対象外】

☐ エフェドリン
KEGG表記例：エフェドリン塩酸塩

☐ プソイドエフェドリン
KEGG表記例：プソイドエフェドリン塩酸塩／硫酸塩

☐ ジヒドロコデイン
KEGG表記例：ジヒドロコデインリン酸塩

☐ ジフェンヒドラミン
KEGG表記例：ジフェンヒドラミン塩酸塩／サリチル酸塩 等

☐ メチルエフェドリン
KEGG表記例：dl-メチルエフェドリン塩酸塩／サッカリン塩

☐ コデイン
KEGG表記例：コデインリン酸塩水和物（＝リン酸コデイン）

☐ デキストロメトルファン
KEGG表記例：デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物 等

☐ ブロモバレリル尿素
KEGG表記例：（表記はそのまま）

→ 1つでもチェックがあれば【対象品】として③へ。

※トローチは外用剤のため対象外。医薬品のドロップは内服扱いなので、液剤・カプセルと同じく成分で判断して③へ。

※紛らわしい対象外：生薬のマオウ／無水カフェイン／プロメタジン等ほかの抗ヒスタミン薬／アリルイソプロピルアセチル尿素

※「サッカリン塩」は甘味料ではなく、苦味の強いエフェドリン系成分を塩の形にして服用時の苦味を抑えるための結合（苦味マスキング）。

③ 薬効分類から「基準日数」を決める（KEGGの薬効分類・外箱の効能）

☐ かぜ薬　☐ 解熱鎮痛薬　☐ 鼻炎用内服薬　→ 基準 ×7（7日）

☐ 上記以外（鎮咳去痰薬・睡眠改善薬・鎮静薬・乗物酔い薬 など）　→ 基準 ×5（5日）

基準日数 ＿＿＿＿ 日

④ 「用法・用量」欄で成人（15歳以上）の1日最大量を出す

1回 ＿＿＿＿（錠・包・mL・カプセル）× 1日最大 ＿＿＿＿ 回 ＝ 1日量 ＿＿＿＿

※小児量・「適宜増減」は使わず、15歳以上の最大量で計算する（18歳未満が買う場合も同じ）。

※成分欄の「成分（N錠中）」は1日量とみなしてよい。

※「就寝前にも服用可」「頓服可」など追加で飲める回数がある場合は、それも足した最大量を1日量とする。

⑤ 包装ごとに消費日数を計算して小容量／大容量を判定

包装規格（例：24錠）	包装数量		1日量（④）		消費日数		基準日数（③）	判定（どちらかに〇）
＿＿＿＿	＿＿＿＿	÷	＿＿＿＿	＝	＿＿＿＿ 日	vs	＿＿＿＿ 日	小容量 ・ 大容量
＿＿＿＿	＿＿＿＿	÷	＿＿＿＿	＝	＿＿＿＿ 日	vs	＿＿＿＿ 日	小容量 ・ 大容量
＿＿＿＿	＿＿＿＿	÷	＿＿＿＿	＝	＿＿＿＿ 日	vs	＿＿＿＿ 日	小容量 ・ 大容量

消費日数 ≦ 基準日数 → 小容量　／　消費日数 ＞ 基準日数 → 大容量

（小数点以下は切り捨てない）

判定と販売時の対応（当てはまる枠に〇）

対象外

①で医薬部外品・食品
または ②で成分なし

通常どおり販売可
（年齢確認・理由確認は不要）

対象・小容量 1個

②で成分あり
⑤で小容量

18歳未満：氏名・年齢を確認
18歳以上：他店での直近の
購入状況を確認

対象・大容量／複数個

⑤で大容量、または
小容量を2個以上

18歳未満：販売不可
18歳以上：購入理由を確認
（正当な理由なしは販売不可）

記入例（改源 26包）

① 医薬品の区分表記あり → ② メチルエフェドリンあり → ③ かぜ薬なので基準7日 → ④ 1回1包 × 1日3回 ＝ 3包
→ ⑤ 26包 ÷ 3包 ＝ 8.7日 ＞ 7日 → 大容量（同じ改源でも 9包 は 3.0日 → 小容量）

判定後は package_verification.csv に1包装＝1行で追記（product／kubun=〇／package／days／judgment／limit／ingredients／daily_dose）。

準拠：厚生労働省 局長通知「指定濫用防止医薬品の指定について」／JSMI「指定濫用防止医薬品の販売制度について」